Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53) 3279-4900 - Email: frpelotasjij@tjrs.jus.br

PETIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL Nº 5014701-13.2024.8.21.0022/RS

REQUERENTE: DOMINICK DE CAMPOS VIEGAS
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PELOTAS / RS
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

D. D. C. V., representado por seus genitores, Sra. Trajana Elisa Cruz de Campos e Sr. Jairo Gouveia Viegas, ajuizou ação para fornecimento de tratamento, com pedido de tutela de urgência, contra o *MUNICÍPIO DE PELOTAS* e o *ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL*. Para tanto, relatou ser portador de transtornos do neurodesenvolvimento (CID 11 6A0Y), necessitando com urgência de atendimento especializado em **Fonoaudiologia**, **Terapia Ocupacional** e **Fisioterapia**, na frequência de três sessões semanais para cada especialidade. Informou a demora inaceitável na prestação dos serviços pela rede pública, o que prejudica seu desenvolvimento. Assim, requereu o deferimento da tutela de urgência pleiteada e, no mérito, a procedência da demanda. Juntou documentos.

Os autos foram remetidos ao Juizado da Infância e Juventude.

Intimada (evento 15, DOC1), a parte autora procedeu à emenda da inicial (evento 27, DOC1).

Foi solicitado apoio técnico através do E-NatJus (evento 29, DOC1).

Emitida nota técnica (evento 30, DOC1), foi deferida a tutela de urgência postulada pela parte autora (evento 32, DOC1).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (evento 71, DOC1). Preliminarmente, alegou a responsabilidade exclusiva do Município que possui gestão plena em saúde. Discorreu sobre a o funcionamento e custeio do atendimento multidisciplinar no âmbito do SUS e da aplicação da normativa atinente à atenção básica de saúde. Sustentou a necessidade de comprovação da incapacidade financeira do autor. Requereu a intimação da parte autora para juntar comprovantes de renda e declarações de bens de seu grupo familiar e a realização de perícia médica via DMJ. No mais, pugnou pela improcedência da ação em face do Estado.

Houve réplica (evento 77, RÉPLICA1).

Citado, o Município de Pelotas apresentou contestação no evento 97, DOC1. Preliminarmente, impugnou os orçamentos apresentados com a inicial, alegando que um deles continha itens não previstos em laudo médico. Arguiu a falta de interesse de agir, sustentando que o Centro de Atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolim teria zerado a fila de espera para crianças de até 6 anos e que a nota técnica do NatJus afastou a urgência do caso. No mérito, defendeu que a pretensão da parte autora se destinaria ao aprimoramento na área da educação, já disponibilizada nas escolas públicas, e que a gestão de verbas da educação e saúde é atribuição exclusiva do Executivo. Por fim, argumentou a ausência de urgência clínica que justificasse a prevalência do autor sobre outros pacientes em lista de espera. Desse modo, requereu a improcedência do pedido.

Instadas a se manifestarem sobre a produção de provas (evento 103, DOC1), o Município requereu a produção de prova pericial para verificar a adequação do número de horas de tratamento (evento 109, DOC1).

O Estado reiterou os termos da contestação e requereu a intimação da parte autora para a juntada de documentos (evento 115, DOC1).

Diante da ausência de elementos técnicos conclusivos sobre a intensidade e frequência das terapias na nota do E-NatJus, foi determinada a realização de perícia médica judicial, além da intimação da parte autora para a juntada de documentos (evento 121, DOC1).

O laudo pericial foi juntado aos autos (evento 150, DOC1), concluindo pela necessidade de continuidade das terapias solicitadas.

O Município de Pelotas impugnou o laudo pericial, requerendo complementação (evento 160, DOC1), o que foi indeferido (evento 163, DOC1). O ente municipal reiterou sua impugnação (evento 166).

O Ministério Público apresentou parecer pela procedência da ação (eevento 159, DOC1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Primeiramente, impõe-se afastar as preliminares arguidas pelo Município de Pelotas e pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Quanto à alegada falta de interesse de agir, esta não prospera. A existência de serviços na rede pública, como o Centro Dr. Rolim, não afasta o interesse processual da parte quando o acesso ao tratamento necessário não é efetivamente garantido em tempo hábil.

A demora na disponibilização das terapias, especialmente para uma criança na primeira infância, configura a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. Ademais, a nota técnica do NatJus, embora tenha afastado a urgência nos termos da definição do Conselho Federal de Medicina, não nega a necessidade do tratamento, cuja imprescindibilidade foi posteriormente confirmada por perícia médica judicial. Portanto, presente o interesse de agir.

A impugnação aos orçamentos, por sua vez, é matéria que se confunde com o mérito da obrigação de fazer e da definição do tratamento a ser custeado, sendo que a decisão judicial se pauta pela necessidade terapêutica comprovada, e não necessariamente pelos valores ou itens de orçamentos privados, quando o tratamento é prestado pela rede pública ou credenciada.

Além disso, o direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado, em sentido amplo, abrangendo solidariamente a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A repartição interna de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão, que pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes federados.

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUTISMO. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Já restou consagrado na jurisprudência que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. Embora haja previsão de que a União fornecerá recursos para a realização dos tratamentos de que necessitam as pessoas que sofrem de TEA, tais recursos são transferidos os Estados e Municípios, de modo que o atendimento deve ser prestado em conjunto pelos entes federados, inclusive nos âmbitos estadual e municipal. O tratamento para crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista encontra previsão na Lei Estadual n° 15.322/2019 (regulada pelo Decreto Estadual n° 56.505, de 19 de maio de 2022), que instituiu a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo no âmbito do Rio Grande do Sul. Inteligência da Resolução nº 322/19 da Comissão Intergestores Bipartite/RS - CIB/RS, que prevê o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com os Municípios. Manutenção da ação junto ao juízo a quo. Desnecessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda. 2. Para o deferimento da tutela antecipada a que alude o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, devem estar preenchidos requisitos essenciais, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que não restou comprovada a verossimilhança do direito invocado pela parte autora da ação, na medida em que não há prova, ao menos em sede de cognição sumária, no sentido de ineficácia dos tratamentos oferecidos pela rede pública de saúde. Determinado o fornecimento do tratamento pelo método tradicional, frente à Lei Estadual n° 15.322/2019 (regulada pelo Decreto Estadual n° 56.505, de 19 de maio de 2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO.(Agravo de Instrumento, Nº 52523310620258217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 02-09-2025)*

Afasto as preliminares suscitadas nas contestações.

Em relação ao mérito propriamente dito, insta referir que o direito à saúde encontra previsão expressa no artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, é claro quanto a esse dever do Estado:

> *Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.*
>
> *Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (...) § 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.*

Não bastasse isso, veja-se que a legislação estadual contém legislação específica sobre a temática, uma vez que a Lei Estadual nº 15.322/2019 institui a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o art. 3º da referida lei enfatiza o atendimento pelo Estado, que poderá ser prestado de forma integrada, em regime de colaboração com os municípios e com assistência da União.

Os argumentos do Município de Pelotas, de que o tratamento pleiteado se enquadraria como "saúde educacional" e de que a intervenção judicial representaria ingerência indevida na gestão de políticas públicas, não merecem acolhida.

As terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, no contexto de transtornos do neurodesenvolvimento, são eminentemente tratamentos de saúde voltados à habilitação e reabilitação, essenciais para mitigar os déficits funcionais e promover o desenvolvimento da criança.

A omissão do Poder Público em fornecer tratamento de saúde indispensável, garantido constitucionalmente, legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de um direito fundamental, não havendo que se falar em violação à separação dos poderes.

Assim sendo e volvendo ao caso concreto, verifica-se que, de acordo com os laudos médicos anexados ao feito, o autor apresenta atraso no neurodesenvolvimento, com suspeita de TEA (CID 11 6A0Y), necessitando de acompanhamento especializado em **Fonoaudiologia**, **Terapia Ocupacional** e **Fisioterapia**.

A necessidade e adequação do tratamento foram exaustivamente confirmadas pela **perícia médica judicial** realizada no curso da instrução (evento 150, DOC1).

O *expert* nomeado por este Juízo, após avaliação presencial do menor, concluiu de forma categórica: *"Concluo que o menino precisa continuar a receber as terapias solicitadas."* A perícia atestou a complexidade do quadro clínico do autor, que inclui, além do atraso no neurodesenvolvimento, um histórico de transplante hepático e outras comorbidades, reforçando a imprescindibilidade da abordagem multidisciplinar.

Em relação a frequência dos tratamentos, o profissional ratificou a adequação das terapias na frequência de 3 (três) sessões semanais.

5. CONCLUSÃO

O processo busca cobertura de tratamentos: Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional para o Autor, DOMINICK DE CAMPOS VIEGAS, transplantado hepático e portador de déficit de desenvolvimentos (TEA, Transtorno do desenvolvimento relacionado à fala e área motora), epilepsia, microcefalia e Fibrose Cística.

O autor está recebendo as terapias por antecipação de tutela e, desde que começou a receber as terapias em três sessões semanais, sua genitora informa que houve melhor no desenvolvimento motor, embora ainda não apresente progressos significativos na fala e linguagem.

Concluo que o menino precisa continuar a receber as terapias solicitadas. Podemos realizar nova avaliação, se for desejo deste Juízo, em 12 a 18 meses.

A impugnação do Município ao laudo pericial, sob o argumento de que o perito teria se baseado apenas em informações da genitora, não se sustenta. O laudo pericial detalha o histórico clínico do paciente, a análise de documentos dos autos e a avaliação presencial, formando um conjunto probatório técnico e robusto que fundamenta sua conclusão.

A percepção da genitora sobre a evolução do filho com as terapias é um elemento relevante, mas não o único, e foi devidamente sopesado pelo perito no contexto de sua avaliação técnica. Portanto, a prova pericial é hígida e suficiente para comprovar a necessidade do tratamento na forma postulada.

Também cumpre relembrar que o autor é criança na primeira infância, merecedor de prioridade absoluta no acesso à saúde, conforme preconiza a Lei nº 13.257/2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. A intervenção precoce é crucial para o prognóstico de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, pois aproveita o período de maior neuroplasticidade cerebral, potencializando os resultados e minimizando prejuízos futuros ao desenvolvimento.

Dentro desse contexto, comprovada a necessidade e urgência do tratamento por meio de prova pericial e robusta documentação médica, e considerando a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, mostra-se imperioso responsabilizar os entes públicos demandados pelo seu fornecimento.

Por derradeiro, imperativa a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência, porquanto a pretensão da parte autora restou acolhida na presente sentença com base num juízo de cognição exauriente, sem mencionar a necessidade de manutenção da medida em face do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito tutelado.

EM RAZÃO DO EXPOSTO, afasto as preliminares suscitadas e, forte no art. 487, I, do CPC, julgo **procedente** o pedido formulado por *D. D. C. V.*, para o fim de confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e condenar o *ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL* e o *MUNICÍPIO DE PELOTAS* a fornecerem ao autor tratamento multidisciplinar especializado nas áreas de **Fonoaudiologia**, **Terapia Ocupacional** e **Fisioterapia**, na frequência de 03 (três) sessões semanais para cada especialidade, conforme laudos médicos e pericial, enquanto perdurar a necessidade, sob pena do bloqueio de valores para custeio em clínica particular.

Saliento que a criança deve ser reavaliada a cada 6 (seis) meses.

Para eventual pedido de bloqueio de valores, deverá ser acostado laudo médico dos profissionais que atendem o menino, no qual deve constar as evoluções no período do tratamento e a necessidade de continuidade, indicando, inclusive, a frequência semanal adequada dos atendimentos.

Sem custas processuais, nos termos do art. 141, § 2º, do ECA.

Condeno o Município de Pelotas e o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, e §8°-A, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, do CPC, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos pelo direito discutido é matéria pacificada nos Tribunais Superiores.

Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ARTECHE HAMILTON, Juiz de Direito**, em 08/09/2025, às 18:01:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090484697v4** e o código CRC **5afc9ef2**.